Árbol de decisión — Rodilla

PhysiQ-Assessment · fase 4 · Rodilla. Cada respuesta puede sumar una hipótesis; se acumulan y todas se confirman con tests en la fase 4b.

REQUISITO PREVIO · Banderas rojas (fase 1) y cribado sistémico (fase 2). Si hay una urgencia, derivar: este árbol no se aplica.

Desvío desde el paso 1 si «SÍ»

1b ¿Algún criterio de Ottawa (≥55 años · cabeza del peroné · rótula aislada · no flexiona 90° · no cargó cuatro pasos ni tras la lesión ni en la consulta)? Y en toda rodilla traumática con dolor anterior, elevación de la pierna extendida. Alternativa a Ottawa: Pittsburgh — contusión o caída MÁS (<12 o >50 años, o no puede caminar); S ≈99 % con E ≈60 %, pide menos radiografías (Seaberg y Jackson 1994; Seaberg 1998). 📝 R1, R3

- **OTTAWA POSITIVO →** 11 Fracturas (Rótula o Meseta Tibial)
- **NO ELEVA LA PIERNA EXTENDIDA →** sin hipótesis
- **NINGUNO →** sin hipótesis

SÍ ↑

1 ¿Hubo un evento lesivo reciente con inflamación inmediata? Rodilla aguda traumática: ¿qué mecanismo cuenta?
📝 G2, G3 · R1, R2, R3, R4

NO →

2 ¿El paciente es mayor de 45 años con rigidez matutina breve (<30 min)? 📝 R5, R8

todas →

2b ¿Niño o adolescente con dolor de rodilla sin mecanismo conocido? → EXPLORAR PRIMERO LA CADERA (epifisiólisis, Perthes). Solo si el cribado es normal, seguir en la rodilla. 📝 G2

Respuestas

SÍ Sensación de "pop", derrame articular rápido e inestabilidad (posible LCA)	→	4 Lesión del Ligamento Cruzado Anterior (LCA) → desvío 1b
SÍ Trauma rotacional con síntomas de bloqueo o chasquidos (posible Menisco)	→	2 Lesión Meniscal → desvío 1b
SÍ Valgo con el pie fijo → LCM (mirar LCA y menisco medial)	→	8 Lesión del Ligamento Colateral Medial (LCM) → desvío 1b
SÍ Golpe en tibia anterior con rodilla flexionada (salpicadero) → LCP y EPL	→	9 Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP) → desvío 1b
SÍ Golpe anteromedial o varo cerca de la extensión → LLE y EPL	→	10 Lesión del Ligamento Lateral Externo y Esquina Posterolateral (LLE y EPL) → desvío 1b
SÍ La rótula «se salió», aprensión al trasladarla lateralmente → INESTABILIDAD ROTULIANA	→	12 Inestabilidad Rotuliana → desvío 1b
SÍ Golpe directo anterior, dolor con extensión resistida, escalón palpable → FRACTURA	→	11 Fracturas (Rótula o Meseta Tibial) → desvío 1b
NO Dolor de inicio insidioso o crónico	→	sin hipótesis

Respuestas

SÍ Edad ≥45 años, dolor relacionado con actividad, rigidez <30 minutos	→	1 Artrosis de Rodilla
NO Perfil más joven o sin patrón degenerativo	→	sin hipótesis

Respuestas

SÍ Cribado de cadera alterado: derivar (epifisiólisis, Perthes)	→	sin hipótesis
SÍ Cribado de cadera normal: seguir en la rodilla	→	sin hipótesis
NO Adulto, o hay mecanismo conocido	→	sin hipótesis

continúa en la página siguiente →

2c ¿Reproduce el dolor de rodilla la exploración de la cadera o de la columna lumbar? 📝 R7

todas →

Respuestas

- **CADERA (artrosis)** — Tratar el origen: valorar en la región Cadera → sin hipótesis
- **COLUMNA LUMBAR (radiculopatía o pseudorradiculopatía)** — Tratar el origen: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NO** — Ninguna de las dos reproduce el dolor de rodilla → sin hipótesis

3 ¿En qué zona se concentra el dolor de rodilla? 📝 R5, R6, R10, R11, R12

todas →

Respuestas

- **Anterior/Retrorrotuliano** — Dolor al cargar en flexión (escaleras, sentadilla) en <40 años → 3 Dolor Patelofemoral (Síndrome)
- **Anterior/Polo inferior rótula** — Dolor exacto en polo inferior, vinculado a saltos o frenadas → 5 Tendinopatía Rotuliana
- **Lateral** — Dolor en cóndilo femoral lateral que empeora al correr → 6 Síndrome de la Banda Iliotibial
- **Medial/Distal** — Dolor 2 cm distal a meseta tibial medial, empeora al subir escaleras → 7 Bursitis de la Pata de Ganso
- **NINGUNA de estas** — Seguir por zona → sin hipótesis

4 Dolor persistente o sin traumatismo, ANTERIOR: ¿qué lo explica?

📝 R5, R7, R10

Respuestas

- **HOFFA** — Recurvatum, test de Hoffa → 13 Síndrome de la Grasa de Hoffa
- **BURSITIS PRERROTULIANA** — Superficial, arrodillarse → 14 Bursitis Pre e Infrarrotuliana
- **INESTABILIDAD ROTULIANA** — Fallo, aprensión → 12 Inestabilidad Rotuliana
- **LESIÓN OSTEOCONDRAL** — Bloqueo → 16 Lesión Osteocondral
- **APOFISITIS POR TRACCIÓN** — En menores → 15 Apofisitis del Adolescente (Osgood-Schlatter, Sinding-Larsen-Johansson)
- **NINGUNO** — Sin dolor anterior o nada de esto lo explica → sin hipótesis

todas →

5 Dolor persistente o sin traumatismo, MEDIAL: ¿qué lo explica? 📝 R5, R7, R8

todas →

Respuestas

- **MENISCO MEDIAL** → 2 Lesión Meniscal
- **ARTROSIS** — Criterios ACR → 1 Artrosis de Rodilla
- **PLICA MEDIAL** → 17 Plica Sinovial Medial
- **NINGUNO** — Sin dolor medial o nada de esto lo explica → sin hipótesis

6 Dolor persistente o sin traumatismo, LATERAL: ¿qué lo explica? 📝 R7, R9

todas →

Respuestas

- **TIBIOPERONEA PROXIMAL** → 18 Disfunción de la Articulación Tibioperonea Proximal
- **MENISCO LATERAL** → 2 Lesión Meniscal
- **NERVIO PERONEO COMÚN** → 19 Neuropatía del Nervio Peroneo Común
- **NINGUNO** — Sin dolor lateral o nada de esto lo explica → sin hipótesis

7 Dolor persistente o sin traumatismo, POSTERIOR: ¿qué lo explica? Descartada siempre la TVP. 📝 R5, R7

Respuestas

- **QUISTE POPLÍTEO** — Signo de Foucher → 20 Quiste Poplíteo (Baker)
- **LCP CRÓNICO** → 9 Lesión del Ligamento Cruzado Posterior (LCP)
- **COLUMNA LUMBAR** — Tratar el origen: valorar en la región Lumbar → sin hipótesis
- **NINGUNO** — Sin dolor posterior o nada de esto lo explica → sin hipótesis

Leyenda

- Pregunta del árbol
- Hipótesis que activa la respuesta
- Derivación médica (el recorrido sigue)
- Sin hipótesis
- 📝 Formulario del paciente (G general, R región)

Al terminar sin ninguna hipótesis activa

La app propone trabajar con «dolor de rodilla inespecífico», revisar los factores psicosociales (fase 1 y SINSS) y reconsiderar las respuestas. Si el cuadro es crónico y el riesgo psicosocial es alto, sugiere considerar también sensibilización central.

Fase 4b · confirmar

Cada hipótesis activa se confirma o descarta con sus tests: ver el esquema de confirmación de rodilla.

Generado desde los datos de la app el 7/11/2026.
PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0